



LES SOINS ATTENTIFS
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE

Soins attentifs et engagement des hommes



Pourquoi les hommes sont-ils importants pour les soins attentifs ?

Le Cadre de soins attentifs (1) met en avant l'importance du rôle des hommes en tant que personnes s'occupant des enfants, aux côtés des mères, des grands-parents et d'autres personnes. Le consensus sur ce point est de plus en plus large, et les données probantes disponibles, bien qu'encore limitées, augmentent également.

Ces données probantes sont synthétisées dans l'encadré intitulé *Les bénéfices de l'engagement des hommes*, à la page 2. Elles indiquent que la participation des hommes, lorsqu'elle est aimante, équitable et non violente, peut contribuer à de meilleurs résultats pour les femmes et les enfants, ainsi que pour les hommes eux-mêmes (2,3,4).

Les travaux de recherche indiquent également qu'il est bénéfique pour les enfants de recevoir des soins attentifs de la part de plusieurs personnes, qu'il s'agisse de femmes

ou d'hommes (4). En outre, des études menées dans plusieurs pays montrent que de nombreux hommes veulent s'impliquer davantage dans la vie de leurs enfants et ont envie d'apprendre à mieux s'en occuper (5).

Pourtant, de nombreux enfants ne bénéficient pas de tous les avantages associés au fait de recevoir des soins attentifs de la part de leurs pères et d'autres hommes qui s'occupent d'eux. Dans la plupart des pays, qu'il s'agisse de pays à revenu faible, intermédiaire ou élevé, ce sont encore les femmes qui s'occupent en grande partie ou exclusivement des enfants à la maison, bien que leur participation au marché du travail augmente (4).

Cette note thématique, destinée aux responsables des politiques et de la conception des programmes, examine les éléments à prendre en compte lors de la conception ou de l'adaptation de services pour favoriser la participation des hommes aux soins attentifs, et explique pourquoi cela est important. Elle résume les données probantes et les enseignements tirés jusqu'à présent, puis recommande des mesures concrètes dans les quatre environnements favorables : les politiques, les services, les communautés et les personnes s'occupant d'enfants. Ces différents axes d'action sont illustrés par des études de cas. Cette note se concentre particulièrement sur les moyens d'action des services de santé, tout en abordant également l'éducation, la protection sociale et d'autres secteurs.

Que sont les soins attentifs ?

Le déroulement de la petite enfance (de la grossesse à l'âge de 8 ans) conditionne le reste de la vie. Nous avons fait de grands progrès en termes de survie de l'enfant, mais nous devons également créer les conditions permettant aux enfants de s'épanouir à mesure qu'ils grandissent et qu'ils se développent. Il faut pour cela donner aux enfants des soins attentifs, en particulier au cours des premières années (de la grossesse à l'âge de 3 ans).

Les soins attentifs comprennent cinq éléments interdépendants et indivisibles : une bonne santé, une nutrition adéquate, la sûreté et la sécurité, la prestation de soins adaptés et des possibilités d'apprentissage précoce. Les soins attentifs protègent les enfants des pires effets de l'adversité et ont des bienfaits à vie et pour plusieurs générations en termes de santé, de productivité et de cohésion sociale.

Les soins attentifs sont possibles si on optimise au maximum chaque interaction avec un enfant. Chaque moment, court ou long, structuré ou non, est l'occasion de s'assurer que les enfants sont en bonne santé, consomment des aliments nutritifs, sont en sécurité et apprennent à se connaître, à connaître les autres et à se familiariser avec le monde qui les entoure. Ce que nous faisons est important, mais la façon dont nous le faisons est plus importante encore.

Bénéfices de l'engagement des hommes

Bénéfices pour les femmes

- La participation et le soutien actifs des hommes pendant la période prénatale sont associés à une probabilité plus importante pour la mère de recevoir des soins prénatals, des soins liés à l'accouchement et des soins postnatals, ainsi qu'à une meilleure préparation de la famille aux éventuelles complications (6). L'implication des hommes peut également contribuer à réduire la dépression post-partum maternelle (6,7). Plusieurs interventions conçues pour encourager l'engagement des hommes ont obtenu ces résultats (2,6,8-10).
- Lorsque les hommes accompagnent les femmes pendant le travail et l'accouchement, cela peut également réduire le stress et l'inconfort de la femme (4,11).

Bénéfices pour les enfants

- Les interventions qui encouragent les pères à améliorer leurs connaissances, leurs attitudes et leurs pratiques en matière de nutrition de la mère et du nourrisson pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, peuvent contribuer à favoriser l'allaitement maternel exclusif et une meilleure nutrition des nourrissons et de leurs mères (12).
- Les soins prodigués par les hommes et leurs interactions directes avec leurs jeunes enfants peuvent également contribuer au développement cognitif, social et émotionnel des nourrissons et des tout-petits, ainsi qu'à la maturité scolaire de leurs enfants et à leurs résultats scolaires ultérieurs (3,9,13,14).
- Les soins prodigués par les hommes et leurs interactions directes avec leurs enfants pendant la petite enfance peuvent également favoriser la santé mentale de leurs enfants et sont associés à une proportion inférieure de problèmes de comportement chez les garçons et de problèmes psychologiques chez les jeunes femmes (4,13-15).

Leur implication peut également aider à développer l'empathie des enfants à l'égard des autres (3,14).

Bénéfices pour les hommes

- La participation des hommes et le partage des responsabilités parentales, dès la grossesse, peuvent améliorer leurs relations avec leurs partenaires et leurs enfants, et contribuer à la santé physique et mentale des hommes, et à leur bonheur (4,11).

Bénéfices pour l'ensemble de la famille

- Les interventions parentales impliquant explicitement les hommes et les femmes en tant que personnes s'occupant des enfants ont des effets positifs attestés sur les relations de couple et familiales. Ces effets comprennent le renforcement de la communication, un processus équitable de prise de décisions et des relations saines entre les hommes et leurs partenaires, ainsi que la réduction de la violence à l'égard des femmes et des enfants (notamment des situations dans lesquelles les enfants sont témoins de violence à l'égard de leurs mères) (8,11,16,17).

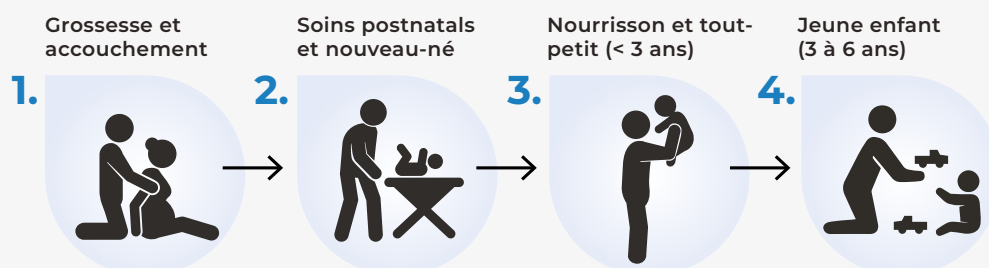
Définitions

Hommes s'occupant d'enfants

Dans cette note thématique, les termes **hommes s'occupant d'enfants** et **pères** sont employés de manière interchangeable, pour désigner les hommes qui jouent un rôle de premier plan dans les soins aux jeunes enfants, qu'il s'agisse de pères biologiques ou adoptifs, de beaux-pères, de grands-pères, d'oncles, de tuteurs ou d'autres membres de la famille. Cette note reconnaît que les hommes s'occupant d'enfants sont divers, en matière d'âges, d'appartenances ethniques, de capacités, d'identités de genre et d'orientations sexuelles ; ils peuvent élever leurs enfants seuls ou avec un partenaire ou un coparent, et ils peuvent ou non vivre avec leurs enfants. Elle reconnaît également que les familles peuvent prendre des formes variées.

Engagement

Les pères et les autres hommes s'occupant d'enfants sont **engagés** lorsqu'ils sont impliqués et réactifs sur le plan émotionnel, et qu'ils jouent un rôle actif dans la protection, le soutien et la promotion de la santé, du développement et du bien-être de leurs enfants. S'ils entretiennent une relation avec la ou les autres personnes qui s'occupent de leur enfant, l'engagement implique également de partager les responsabilités des soins aux enfants et de la prise de décisions au sein du ménage, et d'entretenir une relation saine, respectueuse, non violente, bienveillante et équitable. Il n'existe pas de modèle unique d'engagement parental ; chaque famille doit être soutenue pour prendre les décisions qui lui conviennent le mieux. L'important est que les hommes soient soutenus pour redéfinir les façons de prendre soin de leurs proches afin de leur permettre de construire des relations plus étroites et plus approfondies.



Composantes des soins attentifs

BONNE SANTÉ



Il s'agit de la santé et du bien-être des enfants et des personnes qui s'occupent d'eux. Pourquoi ? On sait que la santé physique et mentale des personnes qui ont la garde d'enfants peut influencer sur leur aptitude à prendre soin d'eux.

NUTRITION ADÉQUATE



S'applique à la nutrition chez la mère et chez l'enfant. Pourquoi ? On sait que l'état nutritionnel de la mère pendant la grossesse a une incidence sur sa santé et son bien-être et sur ceux du fœtus. Après la naissance, l'état nutritionnel de la mère influe sur son aptitude à prodiguer à l'enfant les soins dont il a besoin.

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ



Il est question de la sécurité et de la sûreté de l'environnement dans lequel vivent les enfants et leur famille : dangers physiques, stress émotionnel, risques environnementaux (pollution, p. ex.) et accès à l'eau et à la nourriture.

OPPORTUNITÉS POUR L'APPRENTISSAGE PRÉCOCE



Désigne toute occasion qu'a un bébé, un tout-petit ou un enfant d'interagir avec une personne, un lieu ou un objet dans son environnement. Chaque interaction (positive ou négative) ou l'absence d'interaction contribue au développement cérébral de l'enfant et pose les bases de l'apprentissage ultérieur.

SOINS RÉPONDANT AUX BESOINS



Désigne l'aptitude du parent ou de la personne s'occupant de l'enfant à déceler, comprendre et réagir aux signaux de l'enfant au moment voulu et de façon adaptée. Composante considérée comme fondamentale car des personnes réactives sont mieux à même de contribuer aux quatre autres composantes.

Quels sont les obstacles à l'engagement des hommes ?

À l'échelle mondiale, les femmes continuent de s'occuper principalement des enfants. De nombreux facteurs expliquent l'engagement limité des hommes. Parmi ceux-ci, il existe une idée largement répandue selon laquelle les femmes sont naturellement plus aptes à s'occuper des enfants et à veiller à leur santé et à leur développement, tandis que les hommes n'ont pas les qualités ou les compétences requises, ou ne sont pas intéressés (11,19).

Ces perceptions sont façonnées par les normes de genre : les attentes des communautés et des sociétés, et les règles informelles sur la manière dont les hommes et les femmes doivent se comporter et sur leurs rôles. Ces normes influencent profondément les attentes des hommes et des femmes : pour eux-mêmes en tant que parents, l'un envers l'autre en tant que partenaires et pour leurs enfants. Du fait de ces normes, dans de nombreux contextes, on attend des hommes qu'ils soient des protecteurs et des décideurs, financièrement responsables de leurs enfants, mais moins impliqués dans leurs soins quotidiens, et ils sont élevés dans cette perspective. Quant aux hommes qui veulent s'occuper plus activement de leurs enfants, il arrive qu'ils soient découragés par les hommes et les femmes qu'ils côtoient, y compris leurs partenaires, leur famille ou leurs amis.

Dès leur plus jeune âge, les filles et les garçons sont familiarisés avec ces rôles et ces normes de genre dans le cadre de leurs expériences quotidiennes avec les adultes. Beaucoup de garçons grandissent sans voir d'hommes autour d'eux qui contribuent à s'occuper des enfants. De ce fait, ils n'acquièrent pas la confiance, les connaissances ou les compétences nécessaires pour élever leurs propres enfants plus tard. C'est pourquoi la répartition des tâches entre les femmes et les hommes est importante, ainsi que les relations qu'ils entretiennent.

Ces attentes déterminées par le genre peuvent également influencer la conception et la mise en œuvre de politiques, de services et d'infrastructures pour la petite enfance, qui ignorent souvent les hommes, et vont parfois jusqu'à les exclure. De nombreux services, dans les domaines de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant (SMNE), de la garde d'enfants, de l'éducation préscolaire, de

la protection sociale et de la protection de l'enfance, sont conçus uniquement pour les femmes, ce qui renforce les attentes inégales en fonction du genre concernant les personnes qui doivent s'occuper des enfants.

Comment accroître l'engagement des hommes à l'égard des soins attentifs ?

Il existe un corpus croissant de données probantes indiquant comment accroître l'engagement des hommes à l'égard des soins attentifs et obtenir des résultats positifs.

Cette section présente les enseignements clés tirés de programmes fondés sur des données probantes, qui peuvent également être appliqués à la santé, à l'éducation et à d'autres systèmes qui soutiennent les enfants et leurs familles. (Voir l'encadré *Favoriser l'engagement des hommes : quatre enseignements clés*.)

Favoriser l'engagement des hommes : quatre enseignements clés

- 1 Respecter et promouvoir les droits des filles et des femmes.
- 2 Susciter l'intérêt des hommes et les aider à se soutenir mutuellement.
- 3 Inscrire ce travail au sein d'efforts plus larges visant à parvenir à l'égalité des genres.
- 4 Aider les intervenants et intervenantes de première ligne à examiner leurs propres attitudes liées au genre et à renforcer leurs compétences.

1 Respecter et promouvoir les droits des filles et des femmes

Écouter les femmes et obtenir leur consentement

Les femmes doivent être impliquées dès le départ dans la conception des initiatives ciblant les hommes s'occupant d'enfants. Les services doivent être à l'écoute des besoins et des préoccupations des femmes, mettre l'accent sur l'égalité des genres et le respect des décisions des femmes, et recueillir les rétroactions des femmes sur la qualité des services. Leur consentement est nécessaire pour les initiatives visant à accroître la participation des hommes dans les services destinés aux femmes, tels que les services de maternité.

Encourager la participation des hommes sans désavantager les femmes

Les efforts visant à favoriser l'engagement des hommes ne doivent pas compromettre la sécurité des femmes, leur autonomie ou leur accès aux services. S'ils ne sont pas bien planifiés, ces efforts peuvent entraver les comportements de recours aux soins des femmes et les empêcher d'accéder à des services essentiels : par exemple, lorsque la présence d'un homme est requise pour s'inscrire pour des soins prénatals ou recevoir ces soins, ou lorsque la priorité est donnée aux couples par rapport aux femmes célibataires ou non accompagnées.

Veiller à ce que les prestataires de services ne renforcent pas les inégalités de genre

Si les prestataires ne sont pas bien préparés à interagir avec les hommes aux côtés de leurs partenaires, et à comprendre les déséquilibres de pouvoir entre les femmes et les hommes et à réagir en conséquence, ils peuvent finir par écouter l'homme et à s'en remettre à lui, plutôt qu'à la femme. Ils peuvent ainsi renforcer involontairement les inégalités de genre et limiter la capacité d'action et de décision des femmes. À l'inverse, certains prestataires peuvent ignorer les hommes présents, manquant ainsi l'occasion d'encourager l'engagement des hommes et risquant de décourager une participation future.



Offrir aux femmes s'occupant d'enfants des occasions de réflexion et d'apprentissage

Des approches efficaces ciblent également les femmes, en leur donnant des occasions de réfléchir sur les attitudes et les normes de genre et de les remettre en question, et d'identifier, avec leur partenaire, les avantages du changement et l'organisation qu'ils peuvent trouver ensemble.

2 Susciter l'intérêt des hommes et les aider à se soutenir mutuellement

Proposer des services qui trouvent un écho auprès des hommes et reflètent leurs aspirations

Les services doivent être conçus pour trouver un écho auprès des hommes et refléter leurs aspirations pour leurs enfants, leurs familles et pour eux-mêmes en tant que partenaires et que personnes s'occupant d'enfants. Les intervenants et intervenantes de première ligne doivent reconnaître que les hommes se préoccupent de leurs enfants, veulent ce qu'il y a de mieux pour eux et veulent faire de leur mieux en tant que personnes s'occupant d'eux.

Adopter une approche pratique fondée sur les points forts, ne pas se limiter à donner des informations

Il est important de se fonder sur ce que les hommes savent et mettent déjà en œuvre, et de les aider à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés, renforçant ainsi leur confiance en tant que personnes s'occupant d'enfants. L'apprentissage doit prendre une forme active et pratique, qui correspond mieux aux différents styles d'apprentissage et aux expériences vécues des hommes. S'appuyer sur les normes et les pratiques positives existantes qui soutiennent la participation active des hommes ;

identifier des hommes déjà engagés et les aider à encourager leurs pairs à faire de même.

Adapter le contenu aux hommes dans leur diversité

En général, il ne suffit pas d'ajouter simplement les hommes aux programmes existants d'éducation parentale et de soutien. Il est nécessaire d'adapter les programmes pour répondre aux réalités locales, et d'adapter le contenu aux besoins de différents types d'hommes et de configurations familiales. Il faut ainsi inclure les familles élargies, nucléaires et monoparentales, les parents adoptifs, ainsi que les pères non résidents ou adolescents. Veiller à impliquer les familles vulnérables telles que les populations de réfugiés et de personnes déplacées ainsi que les personnes ayant des capacités, des identités de genre et des orientations sexuelles différentes.

Créer des environnements sûrs et bienveillants pour permettre aux hommes de parler et de s'exercer

Les hommes ont besoin d'un espace sûr pour exprimer leurs préoccupations, renforcer leur confiance et mettre en pratique de nouvelles compétences, comme l'établissement de liens affectifs avec un nouveau-né grâce au contact peau à peau, le bain, l'alimentation des jeunes enfants et la gestion de leur comportement. Les hommes doivent également pouvoir apprendre et mettre en pratique des comportements caractéristiques d'une relation équitable avec leurs partenaires, tels que le règlement non violent des conflits, la communication et la prise de décisions partagée.

Encourager le soutien et l'apprentissage par les pairs

Il est important de favoriser le soutien par les pairs et de donner aux participants la possibilité d'apprendre les uns des autres et de travailler ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes. Encourager les hommes à établir des relations d'entraide avec leurs amis et pairs, favorisant ainsi un changement durable à l'échelle de la communauté.

3 Inscrire ce travail au sein d'efforts plus larges visant à parvenir à l'égalité des genres

Ne pas se concentrer uniquement sur l'éducation parentale

Il peut s'avérer insuffisant de se limiter à inclure les hommes dans les programmes d'éducation parentale pour faire évoluer les normes de genre. Il est nécessaire de déterminer et de corriger les facteurs qui influencent les comportements des hommes, ainsi que les obstacles à leur engagement, notamment les normes de genre restrictives. Veiller à ce que ce processus soit dirigé par la communauté, centré sur la communauté et respectueux des valeurs de la communauté. Cela peut aussi nécessiter de travailler avec les prestataires de services, d'influencer les politiques et de communiquer sur les changements sociaux et comportementaux, comme indiqué ci-dessous.

Proposer des occasions explicites de réflexion sur les normes, les attitudes et les rôles liés au genre

Donner aux personnes s'occupant d'enfants et aux membres de la communauté, quel que soit leur genre, des occasions de réfléchir à la manière dont les normes de genre influencent les rôles des hommes et des femmes s'agissant de s'occuper des enfants, leurs relations, ainsi que la manière dont les filles et les garçons sont élevés. Le contenu doit être adapté aux normes de genre, aux politiques et aux obstacles

à la participation des hommes au niveau local. Utiliser des méthodes d'apprentissage participatif pour aider les hommes à prendre conscience des bénéfices que la modification de leurs attitudes et des dynamiques de pouvoir peut apporter aux femmes, aux enfants et à eux-mêmes.

Comprendre que les hommes, les femmes et les familles peuvent faire face à des réactions négatives

Lorsque les hommes bravent les normes en assumant des responsabilités traditionnellement attribuées aux femmes, il arrive que ceux-ci et leurs partenaires soient ridiculisés, ostracisés ou pire encore. Ces réactions peuvent venir de partenaires, d'amis, de membres de la famille, de responsables communautaires ou de prestataires de services. Il peut être nécessaire d'apporter un soutien aux hommes, aux femmes et aux couples concernés afin de limiter ces risques, tout en travaillant avec les communautés pour faire évoluer les normes de genre.

Aider les couples à renforcer leurs compétences relationnelles et parentales

Un travail doit être mené avec les couples pour renforcer les compétences relationnelles, à savoir la communication, la prise de décisions partagée et la gestion des conflits ; elles permettent d'entretenir des relations respectueuses de l'équité entre les genres et de favoriser les soins attentifs. Le renforcement des relations peut aider à prévenir la violence entre partenaires intimes, améliorer l'environnement familial dans lequel les enfants sont élevés et réduire le risque de violence à l'égard des enfants (15). Le travail mené avec les couples peut également promouvoir le partage des responsabilités avec les hommes pour les soins aux enfants et les tâches ménagères, et encourager les personnes s'occupant d'enfants à élever garçons et filles de manière équitable.

Faire évoluer les attitudes des personnes exerçant une influence importante sur les hommes

Ces personnes peuvent inclure les partenaires, les parents et beaux-parents, les frères et sœurs et d'autres membres de la famille, les responsables communautaires et religieux, les aînés, les pairs et les principaux prestataires de services. Ces personnes peuvent toutes jouer un rôle clé, en restreignant ou en favorisant l'engagement des hommes auprès de leurs enfants ; il est donc primordial de faire évoluer leurs attitudes et leurs attentes.

Impliquer les hommes, les femmes et les responsables communautaires dans le processus de conception

Cette coopération permet de garantir que les programmes reflètent les besoins, les ambitions, les peurs et les difficultés des hommes en tant que personnes s'occupant d'enfants, et qu'ils prennent également en compte les souhaits et les préoccupations des femmes concernant la participation accrue des hommes aux soins aux enfants. Elle aide également à identifier les modalités, les horaires et les lieux appropriés, ainsi qu'à sélectionner et à recruter des prestataires ou à mettre en place une équipe de confiance et respectée.

4 Aider les intervenants et intervenantes de première ligne à examiner leurs propres attitudes liées au genre et à renforcer leurs compétences

Aider les personnes qui travaillent avec les hommes et les familles à réfléchir à leurs propres attitudes liées au genre

Les éducateurs et éducatrices, animateurs et animatrices, personnels de santé et autres prestataires de services partagent souvent les attitudes et les attentes du reste de la population concernant le genre et les soins aux enfants. Il faut leur laisser du temps et de l'espace pour réfléchir, afin qu'ils puissent comprendre l'engagement des hommes et l'égalité des genres, et croire en ces évolutions.

Aider les intervenants et intervenantes de première ligne à encourager l'engagement des hommes

Pour soutenir efficacement l'engagement des hommes s'occupant d'enfants, les intervenants et intervenantes de première ligne ont besoin d'une supervision de soutien, d'un mentorat et d'un accompagnement continus. Cela les aidera à susciter la réflexion et le dialogue, à écouter et à conseiller (plutôt que de sermonner et de réprimander), et à gérer les conflits avec tact.



Un futur père fier soutient avec amour sa partenaire, partageant la joie de leur famille grandissante au Rwanda. © Perttu Saralampi

Comment agir ?

Une approche pansociétale est nécessaire pour atteindre le plein potentiel des hommes en matière de soins attentifs. Cela nécessite des évolutions des politiques, des services, des communautés et des familles.

Les quatre parties suivantes de cette note thématique suggèrent des mesures qui peuvent être prises pour favoriser l'engagement des hommes dans chacun des quatre environnements favorables pour les soins attentifs (voir Figure).

Politiques favorables

Les mesures suggérées en matière de politiques comprennent des lois et règlements clés qui orientent les services et les programmes liés à la petite enfance, et qui ont une incidence sur la capacité des hommes à prodiguer des soins attentifs.

Examiner les politiques et les réglementations dans le secteur de la santé

Permettre la participation des hommes, avec le consentement des femmes, aux soins prénatals et à l'accouchement, et aux services de soins postnatals pour les femmes, veiller à bénéficier de suffisamment d'espace et d'intimité, et encourager la participation des hommes aux services essentiels de santé de l'enfant.

Adapter les modes opératoires normalisés, les programmes de formation des personnels de santé et les réglementations sur les infrastructures afin de favoriser l'engagement des hommes.

Veiller à ce que des effectifs suffisants, des charges de travail acceptables et des budgets établis soient en place pour aider les membres du personnel à favoriser l'engagement des hommes, tout en assurant des soins rapides et de qualité pour tous.

Élaborer des politiques, des plans et des budgets complets pour le développement de la petite enfance

Figure. Environnements favorables pour les soins attentifs (1).



Adopter une approche centrée sur la famille et qui transforme les aspects relatifs au genre lors de l'élaboration ou de la révision des politiques, des plans et des budgets ; cette approche doit reconnaître les différentes structures familiales et le fait que des personnes de toute identité de genre prodiguent des soins. (Voir l'étude de cas sur le Chili.)

Déterminer des interventions, dans différents secteurs, visant à permettre et à favoriser l'engagement des hommes à l'égard des soins attentifs, et prévoir les budgets en conséquence.

Renforcer les politiques d'éducation et de protection de la petite enfance

Prévoir et financer une formation préalable ou en cours d'emploi pour les personnels éducatifs et de gestion sur la manière de favoriser la participation des hommes s'occupant d'enfants à l'apprentissage de leurs jeunes enfants.

Revoir les stratégies de recrutement et de perfectionnement professionnel afin d'augmenter le nombre d'hommes qui s'orientent vers les professions de l'éducation et de la protection de la petite enfance et qui restent dans ce secteur.

Veiller à ce qu'une attention soit portée au congé parental rémunéré dans les politiques de protection sociale

Veiller à ce que les femmes bénéficient d'un congé de maternité rémunéré adéquat, et proposer un congé parental aux hommes. Les hommes sont plus susceptibles de prendre ce congé lorsqu'il est flexible, d'une durée adéquate, rémunéré et non transférable à leurs partenaires. (Voir l'encadré sur le congé parental et l'étude de cas sur les Philippines.)

Élargir les politiques de congé parental afin de permettre aux hommes et aux femmes s'occupant d'enfants de prendre des congés pour leurs enfants si le besoin se présente, par exemple, si un enfant est malade ou si les services de garde d'enfants sont limités.

Suivre et évaluer les politiques et les efforts déployés

Suivre la participation des hommes (dans le cadre des services et au-delà), mais veiller à ce que la participation en elle-même ne soit pas considérée comme un objectif. Le suivi et l'évaluation doivent plutôt être axés sur la qualité des services et sur l'amélioration des résultats, en particulier pour les enfants et les femmes, qui constituent les objectifs à atteindre.

Assurer un suivi des efforts déployés pour augmenter la participation des hommes aux services, en observant leur prestation et en recueillant les observations des utilisateurs. Cela est essentiel pour identifier tout impact négatif sur l'accès des femmes aux services de santé, leur expérience de ces services, ou encore la qualité de ceux-ci. Cela peut également garantir que la participation des hommes ne renforce pas involontairement des dynamiques de pouvoir inéquitables et ne porte pas atteinte à la capacité d'action et à l'autonomie des femmes.

Faciliter la mobilisation communautaire grâce à des mécanismes de responsabilisation sociale, tels que le suivi participatif, les rapports et fiches d'évaluation par les citoyens et citoyennes, afin de surveiller la qualité des services et de réaliser des adaptations pour encourager l'engagement des hommes et répondre aux besoins et aux priorités de la communauté.

Congé parental pour les hommes s'occupant d'enfants

Le congé parental offre aux hommes une occasion clé d'établir des liens affectifs avec leurs enfants dès le départ et de s'occuper d'eux plus activement. Ce congé peut permettre aux hommes d'apporter à leurs partenaires un soutien post-partum important, sur les plans physique, émotionnel et social. Il permet également de partager les responsabilités domestiques et liées à la garde des enfants, en particulier si les couples peuvent décider du moment où ils prennent ce congé.

Néanmoins, les politiques de congé parental sont très variables d'un pays à l'autre. Moins de la moitié des pays accordent un congé aux pères,

et il n'est accordé qu'aux salariés du secteur formel dans la plupart des cas (19). Lorsqu'un congé est accordé, de nombreux hommes ne le prennent pas, soit parce qu'il est trop court ou mal rémunéré, soit parce qu'ils craignent d'être stigmatisés et marginalisés par leur employeur (4,19). Dans d'autres cas, les politiques ne bénéficient pas à toutes les personnes s'occupant d'enfants. Ainsi, elles excluent souvent les personnes à leur compte, sous-employées ou sans emploi, celles qui travaillent dans le secteur informel, et celles qui font partie de familles non traditionnelles.

Les politiques de congé parental rémunéré doivent faire l'objet

d'un suivi et être élargies afin de garantir que toutes les personnes s'occupant d'enfants en bénéficient. Les responsables et les membres du personnel doivent comprendre les bénéfices du congé parental, pour leurs lieux de travail, ainsi que pour les hommes et leurs familles. Il faut également encourager les hommes à prendre leur congé parental, en luttant contre la stigmatisation qui y est associée et en faisant évoluer les cultures de travail qui les dissuadent d'en profiter.

Pour plus d'informations, consulter cette [note d'information de l'UNICEF sur le congé parental](#).

CHILI

Une approche centrée sur la famille et qui promeut l'égalité des genres

Chile Crece Contigo (« Le Chili grandit avec toi ») est un système national global visant à protéger les enfants et à les aider à atteindre leur plein potentiel de développement, qui accompagne les familles de la période prénatale jusqu'à l'âge de 9 ans. Il tire parti de chaque rencontre entre les enfants, les personnes qui s'en occupent et les services de santé, et coordonne la prestation de services dans l'ensemble du secteur public, notamment l'éducation et le développement social.

Ayant pris acte du fait que les programmes précédents avaient tendance à se concentrer uniquement sur les mères, le système Chile Crece Contigo utilise le concept de « parentalité » pour dépasser la conception des rôles de père et de mère comme des activités distinctes (20). Les pères sont encouragés à être présents à la naissance de leur enfant, et les documents relatifs au programme, notamment des vidéos sur la paternité active et la coresponsabilité, montrent de nombreuses images d'hommes s'occupant d'enfants.

De nombreuses études ont démontré les effets positifs de Chile Crece Contigo sur le développement des enfants et sur la satisfaction des parents à l'égard de la vie. D'autres pays de la région adoptent également des politiques plus complètes concernant la petite enfance, qui incluent les pères, comme le *Sistema de Cuidados* (« Système de soins ») en Uruguay.

Pour plus d'informations, consulter [l'étude de cas détaillée dans le BMJ](#).



Un père porte tendrement son nouveau-né. © Plan International Ecuador

Accorder un congé parental rémunéré aux pères

En 1996, les Philippines ont adopté le *Paternity Leave Act*, une loi sur le congé de paternité qui prévoyait un congé de paternité rémunéré de sept jours pour les pères mariés vivant avec leur conjointe féminine. Elle prévoyait que ce congé soit rémunéré par les employeurs dans le secteur privé et public, et qu'il puisse être utilisé pour un maximum de quatre enfants. Il était applicable en cas de naissance, de fausse couche, d'avortement et d'adoption d'enfants de moins de 7 ans.

En 2019, une nouvelle loi a élargi les droits aux congés de maternité et de paternité. Elle permettait à une mère de transférer jusqu'à sept jours de congé parental rémunéré à son partenaire, quelle que soit leur situation matrimoniale. Cette législation démontre l'engagement du gouvernement envers l'implication des pères dans les soins attentifs. Depuis lors, l'Autorité nationale de l'économie et du développement a recommandé des élargissements supplémentaires à la fois du congé de paternité et du congé parental. Elle les considère comme des

leviers importants pour accroître les opportunités d'emploi des femmes et pour promouvoir l'égalité des genres concernant les soins aux enfants au sein de la famille.

Malgré ces politiques, le nombre de pères choisissant de profiter du congé paternité aux Philippines reste faible pour plusieurs raisons. Plus de la moitié des travailleurs sont employés dans le secteur informel et n'ont donc pas accès au congé de paternité financé par l'employeur. Il existe des normes de genre restrictives concernant les rôles et les responsabilités des parents. Les hommes craignent d'être pénalisés pour leur carrière et sur le plan économique s'ils prennent un congé. En outre, les hommes ne peuvent prendre ce congé prévu par la loi que s'ils sont mariés, ce qui exclut de nombreux autres types de familles dans la société (21).

Cela montre que, bien que le congé parental constitue un levier politique important, il doit être accompagné d'autres stratégies pour que les hommes en profitent.



Un père regarde son enfant avec amour et fierté. © Plan International Philippines

Services d'aide

Les mesures suggérées dans cette partie visent à améliorer les services, notamment les institutions clés (et leurs personnels) qui fournissent des services de santé, de protection sociale, de garde d'enfants et d'éducation précoce aux jeunes enfants et aux personnes qui s'en occupent.

Mesures concernant les services de SMNE

Inviter les hommes dans les services de maternité, avec la permission des femmes

Les personnels de santé peuvent inviter les hommes à assister aux visites prénatales, ainsi qu'au travail, à l'accouchement et aux soins postnatals, mais uniquement si les femmes souhaitent leur présence. Mettre en avant auprès des personnels de santé et des personnes utilisant les services le fait que la participation des hommes n'est pas nécessaire pour que les femmes puissent accéder aux soins.

Inclure les pères en tant que coparents dans les services de santé de l'enfant

Inscrire les hommes, au même titre que les femmes, en tant que personnes s'occupant de l'enfant à titre principal et comme points de



contact pour les services de santé de l'enfant et de la famille. Inviter les hommes à participer au suivi de la croissance, aux vaccinations et aux visites de suivi médical de leurs enfants, et adapter les activités de sensibilisation, y compris les visites à domicile, pour s'adresser à eux.

Rendre les établissements de santé accueillants pour les hommes

Les personnels de santé peuvent accueillir les hommes qui participent, leur fournir des informations personnalisées et leur donner des conseils, ainsi qu'à leurs partenaires, plutôt que de leur faire la leçon.

D'autres changements peuvent favoriser la participation des hommes, tout en respectant l'intimité et la dignité des femmes. Cela inclut la mise à disposition de suffisamment de chaises et d'espace pour que les hommes puissent être présents, ainsi que de salles d'accouchement privées, de rideaux permettant de créer des espaces distincts dans les pièces partagées, de salles de bains séparées, et de documents d'information (comme des affiches et des brochures) montrant les hommes en tant que personnes s'occupant d'enfants.

(Voir l'encadré intitulé *Impliquer les hommes dans les services de SMNE*.)

Des efforts peuvent également être faits pour rendre les services plus accessibles pour les hommes et les familles, par exemple en proposant des services après le travail ou en dehors des établissements de santé.

Former les personnels de santé dans les établissements et les communautés

Veiller à ce que les personnels de santé connaissent les liens entre l'égalité des genres, l'engagement des hommes et les résultats en matière de santé pour les femmes et les enfants. Aider les personnels de santé à réfléchir à leurs propres attitudes et utiliser des exercices pratiques, tels que le jeu de rôles, pour renforcer leurs compétences et leur confiance lors des interactions avec des hommes et des couples dans le cadre des visites de routine pour les services de SMNE et de nutrition. Former les personnels à identifier et à soutenir les femmes et les filles qui sont survivantes de violences entre partenaires intimes, et à savoir quand NE PAS encourager la participation des hommes. (Voir l'étude de cas sur le Ghana.)

Impliquer les hommes dans les services de SMNE

Il est possible d'adapter les services de SMNE et de former les personnels de santé pour leur donner les moyens de mieux encourager et soutenir l'engagement des hommes à l'égard des soins attentifs.

Dès la grossesse et la période postnatale, les services de SMNE peuvent encourager l'engagement des hommes et leur donner la confiance, les connaissances et les compétences nécessaires pour soutenir une grossesse en bonne santé, garantir l'accès en temps opportun des femmes et des enfants

aux services de santé essentiels, et soutenir la nutrition de la mère et du nourrisson.

Ces services peuvent également aider les hommes à comprendre l'influence directe de leur comportement sur le développement et le bien-être de leurs enfants. Ils peuvent encourager les hommes à établir des liens affectifs avec leurs enfants, à créer des interactions agréables et stimulantes, et à participer aux soins quotidiens. En outre, lorsque les services de SMNE s'adressent aux hommes aux côtés de leurs

partenaires, ils peuvent favoriser des relations de couple plus équitables et un soutien mutuel.

La participation des hommes aux services de SMNE constitue également une occasion de promouvoir le recours aux soins des hommes. Par exemple, les services peuvent dépister la dépression paternelle, qui affecte le bien-être des hommes et leur capacité à prodiguer des soins attentifs, et à une incidence sur la santé mentale et le bien-être de leurs partenaires (22).

Revoir le contenu des séances de préparation des futurs parents et des programmes d'éducation parentale

Adapter les programmes d'éducation parentale ou les séances de préparation des futurs parents, animés par les personnels de santé ou mis en œuvre par le système de santé, afin de mieux inclure les hommes. Impliquer les hommes et les femmes dans la conception ou l'adaptation, et afin d'identifier les meilleures façons de s'adresser aux hommes. Les inviter et les encourager à participer, que ce soit dans le cadre de séances réservées aux hommes ou en couple. Veiller à inclure les familles vulnérables, y compris les populations de réfugiés et de personnes déplacées, ainsi que les hommes dans toute leur diversité (âge, identité de genre, appartenance ethnique, géographie et capacités) et les différentes configurations familiales.

Mesures concernant les services d'apprentissage précoce

Intégrer les hommes à un processus plus large visant à accroître la participation des personnes s'occupant d'enfants

Les services d'apprentissage précoce peuvent être formels ou informels et sont proposés dans différents espaces tels que les crèches, les garderies et les établissements préscolaires. Leurs responsables, prestataires de soins et personnels éducatifs peuvent promouvoir la participation des hommes dans le cadre d'un processus plus large visant à renforcer les relations avec les familles et à encourager les personnes s'occupant d'enfants à participer davantage aux soins et à l'éducation de leurs enfants. Ces espaces peuvent inviter explicitement les hommes aux réunions destinées aux personnes s'occupant d'enfants et aux journées d'activités, et les organiser à des moments où les hommes et les femmes peuvent y assister, en veillant à ne pas donner la priorité aux hommes par rapport aux femmes.

Revoir les programmes d'apprentissage précoce et les supports pédagogiques

Adapter les programmes, les jeux et les supports pédagogiques afin qu'ils remettent en question les attentes liées aux genres concernant les comportements et les rôles des hommes et des femmes, et qu'ils proposent des représentations positives des hommes en tant que personnes prodiguant des soins attentifs.

Recruter plus d'hommes

Les crèches, les garderies et les établissements préscolaires peuvent également recruter des hommes en tant que prestataires de soins et éducateurs de première ligne, et non uniquement pour des postes de direction. Les jeunes enfants (et leurs familles) ont ainsi des modèles masculins positifs, et cela leur donne l'occasion de voir des hommes s'occuper d'enfants aux côtés des femmes.

Mesures concernant la protection de l'enfance et des services sociaux

Adapter les services existants pour favoriser l'engagement des hommes

Travailler avec les intervenants et intervenantes de première ligne et les familles pour déterminer comment les mécanismes de protection de l'enfance et les services de protection sociale existants qui s'adressent à des familles ayant de jeunes enfants pourraient être adaptés pour impliquer les hommes s'occupant d'enfants. La conception et le contenu de ces services, tels que les programmes d'aide sociale, de transferts en espèces ou les réseaux de protection de l'enfance, pourraient être adaptés pour promouvoir la responsabilité partagée des hommes en matière de soins aux enfants et de tâches domestiques, ainsi que pour renforcer les relations entre les coparents et prévenir la violence. Former ces prestataires de services à s'adresser aux hommes, à les accueillir et à les conseiller en adoptant une approche fondée sur les points forts.

Le saviez-vous ?

Le cerveau humain se forme à plus de

80%

au cours des trois premières années de vie.

Les soins et le soutien apportés au cours des toutes premières années par les parents et les autres personnes s'occupant d'enfants sont essentiels à un bon développement cérébral.

0-3

Le cerveau humain se développe plus rapidement entre la conception et l'âge de 3 ans qu'à tout autre moment.

Encourager, protéger et soutenir les enfants et les personnes qui s'en occupent est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.

Au cours des premières années de vie, les parents, les membres de la famille proche et les autres personnes s'occupant d'enfants sont les personnes les plus proches du jeune enfant et donc les plus à même de lui prodiguer des soins attentifs. Afin que les personnes s'occupant d'enfants aient le temps et les ressources nécessaires pour leur prodiguer des soins attentifs, il faut que des politiques, des services et des soutiens communautaires soient en place.

Des soins attentifs améliorent la santé, la productivité et la cohésion sociale tout au long de la vie et les bénéfices se ressentent également pour la génération suivante.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 250 millions d'enfants de moins de 5 ans, soit plus de **40 % des enfants**, sont exposés à un risque accru de ne pas atteindre leur plein potentiel de développement en raison de la pauvreté et d'un défaut de soins (23).

Chaque **dollar supplémentaire investi** dans le développement de la petite enfance peut **rapporter entre 6 et 17 USD** (24).

Former les personnels de santé

Depuis 2016, Plan International travaille en collaboration avec le système national de santé du Ghana pour mettre en œuvre le programme *Strengthening Health Outcomes for Women and Children* (SHOW). Ce programme vise à garantir que les adolescentes, les femmes et leurs partenaires masculins ont accès à des services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et de SMNE qui tiennent compte des questions de genre et qui sont adaptés aux adolescentes et adolescents. Outre le travail mené directement auprès des hommes, le programme SHOW collabore également avec les bureaux de la santé régionaux et de district pour renforcer les capacités des établissements de santé et des prestataires de services à favoriser l'engagement des hommes dans les services de SSR et de SMNE.

Au Ghana, des programmes de formation ont été menés pour les agents et agentes de santé communautaires bénévoles et pour les personnels de santé, à la fois en établissement et dans les communautés. Ces programmes abordaient les obstacles communs liés au genre auxquels les femmes et les hommes sont confrontés pour accéder et avoir recours aux services de santé. Ils visaient également à améliorer les compétences des prestataires pour accueillir et faire participer les hommes lors des consultations de routine et des visites à domicile, et leur ont permis de mettre en pratique ces compétences. De plus, les responsables de la santé ont pu acquérir des compétences en matière de supervision de soutien. Afin de permettre aux hommes de participer aux services de SMNE

(tout en respectant l'intimité des femmes), de petites améliorations peu coûteuses des infrastructures ont été apportées dans les établissements de santé.

Les résultats finaux ont démontré une augmentation significative de la proportion de services de santé ciblés répondant aux critères de qualité et de prise en compte des questions de genre. Il y a également eu une augmentation de la demande et de la satisfaction des femmes à l'égard des services prénatals, liés à l'accouchement et postnatals. Les hommes ont montré une meilleure connaissance des messages clés sur l'égalité des genres et ont indiqué avoir des attitudes plus positives à l'égard du recours aux services par leurs partenaires et de la prise de décisions par les femmes de manière autonome concernant leur santé. Les hommes comme les femmes ont fait état d'une augmentation du soutien des

hommes à l'égard du recours aux services de santé par les femmes, bien que cette augmentation ait été inférieure à l'objectif initial du programme. Les données indiquent qu'il y a deux raisons à cela. Premièrement, le programme a accru les attentes quant à ce qui constitue un « très bon » soutien de la part des hommes, ce qui signifie que les hommes étaient plus susceptibles d'être considérés comme en dessous des attentes. Deuxièmement, la pandémie de COVID-19 et les mesures de lutte anti-infectieuse ont entraîné une augmentation des tâches de soins non rémunérés dont les femmes ont assumé une part disproportionnée, avec un soutien limité de la part des hommes en général.

Pour plus d'informations, consulter la [présentation générale du programme SHOW](#) et [l'approche en faveur de l'engagement des hommes](#).



Autonomisation des communautés

Les mesures suggérées dans cette partie peuvent être prises avec les communautés pour créer un environnement favorable à l'engagement des hommes. Un travail est notamment à mener pour faire évoluer les attitudes communes liées au genre et promouvoir des normes positives qui soutiennent la participation des hommes.

Aider les communautés à mener le changement

Créer des occasions pour que les membres de la communauté réfléchissent et échangent au sujet des implications des attitudes, normes et attentes liées au genre concernant la participation des hommes aux soins aux enfants et leur contribution au développement des enfants, l'objectif étant de parvenir à un accord sur les changements souhaités. Profiter de

ces occasions, comme des dialogues communautaires, pour identifier également des normes positives sur lesquelles s'appuyer, pour sensibiliser aux politiques en faveur de l'engagement des hommes et pour combattre les idées fausses.

Travailler en collaboration avec les responsables communautaires

Soutenir les responsables communautaires, qu'il s'agisse de responsables religieux, traditionnels ou politiques, ainsi que d'autres acteurs influents (comme des personnalités médiatiques) qui incarnent déjà la paternité engagée ou qui peuvent être des alliés pour promouvoir l'engagement des hommes. (Voir l'étude de cas sur la Géorgie.) Veiller à ce que ces responsables aient également la possibilité de réfléchir aux implications des normes de genre dans leur propre vie, et soutenir le travail mené avec leurs communautés pour mener, promouvoir et encourager le changement. Travailler en collaboration avec ces responsables pour sensibiliser aux bénéfices de l'engagement des hommes, pour faciliter les efforts communautaires visant à lutter contre les normes de genre inéquitables qui entravent l'engagement des hommes, et pour renforcer les normes et pratiques

existantes ou émergentes qui soutiennent la responsabilité partagée des hommes en matière de soins aux enfants.

Investir dans l'éducation en santé et la promotion de la santé

Utiliser les communications sur les changements sociaux et comportementaux pour faire évoluer progressivement les attitudes, les attentes et les pratiques autour de la participation des hommes aux soins. Montrer des représentations positives d'hommes qui établissent un lien émotionnel avec leurs enfants et qui s'impliquent en tant que personnes leur prodiguant des soins attentifs, tout en assumant leur part de responsabilités et en soutenant leurs partenaires. Le contenu doit être fondé sur des données probantes et pertinent : c'est pourquoi il est important de procéder à l'élaboration et à des essais avec les communautés. Utiliser des moyens d'information appropriés et des canaux numériques – affiches, panneaux d'affichage, cinéma, radio, téléphone portable, Internet – et œuvrer pour intégrer le contenu aux messages d'intérêt public existants (p. ex. santé ou éducation) ou à la publicité du secteur privé. (Voir l'étude de cas sur la Géorgie.)

GÉORGIE

Une campagne nationale pour faire évoluer les attitudes et les comportements

En 2015, le bureau pays du FNUAP pour la Géorgie et l'organisation non gouvernementale Care Together ont lancé la campagne nationale MenCare. Elle visait à promouvoir la participation des hommes de manière équitable et non violente en tant que pères et pourvoyeurs de soins, afin d'améliorer le bien-être des familles, l'égalité des

genres et la santé des mères, des pères et des enfants. La campagne s'appuyait sur une étude de 2013 concernant les hommes et les rapports entre femmes et hommes dans le pays, qui a montré que peu d'hommes contribuaient à s'occuper quotidiennement de leurs enfants. L'étude a également révélé que les stéréotypes de genre empêchaient les hommes d'être des pères, des maris, des partenaires et des membres de la famille attentionnés.

Inspirée par la [campagne mondiale MenCare](#), la campagne géorgienne adopte une approche positive et utilise des moyens innovants pour générer le dialogue et faire évoluer la perception de la participation des hommes aux soins aux enfants. Cela inclut des projets photographiques, des blogues de pères, des lectures de livres pour enfants par des pères célèbres, des chansons populaires, des recueils d'histoires, une émission de télé-réalité avec des personnalités masculines, la «

Coupe des pères » (soutenue par la Fédération géorgienne de football), et des célébrations de la fête des pères sur les médias sociaux. Cette campagne primée est bien connue non seulement par les hommes, mais également par leurs familles et leurs communautés, ainsi que par les responsables politiques.

S'appuyant sur le succès de la campagne, plusieurs interventions destinées aux pères ont été lancées, notamment des groupes de pères, des séminaires d'une journée dans le cadre de l'initiative *Men Talking to Men*, et un programme de *Fathers' School* de huit séances. La campagne a évolué au fil des années, en commençant par la promotion d'une paternité engagée, et en progressant vers des partenariats équitables, puis vers des politiques favorables à la famille telles que le congé parental.

Pour plus d'informations, consulter la [brochure de la campagne MenCare en Géorgie](#).





Un père et son fils jouent ensemble. © Alfred Tschager

Capacités des personnes s'occupant d'enfants

Les approches suggérées dans cette partie visent à renforcer les capacités des personnes s'occupant d'enfants. Ces interventions sont souvent mises en œuvre par le personnel d'organisations non gouvernementales, par des pairs masculins, par des agents et agentes de santé communautaires, ou par des membres et des responsables des communautés.

Utiliser les services existants pour s'adresser aux hommes

Les approches visant à renforcer les capacités des personnes s'occupant d'enfants peuvent être mises en œuvre directement ou indirectement par le biais de services existants, comme décrit dans la section précédente consacrée aux services d'aide. Comme pour les services, les intervenants et intervenantes de première ligne ont besoin d'un soutien pour examiner leurs propres attitudes liées au genre, ainsi que d'une formation sur la manière de conseiller les hommes et de répondre à la violence familiale. Les interventions auprès des hommes doivent être complétées par des efforts similaires pour s'adresser aux

femmes, idéalement avec certaines séances séparées et d'autres ensemble.

Créer des possibilités de soutien par les pairs

Les interventions de groupe créent des espaces sûrs pour l'apprentissage mutuel, la réflexion critique et le dialogue, le développement des compétences et le soutien par les pairs. Elles peuvent donner aux personnes participantes la possibilité d'intégrer ce qu'ils apprennent à leur expérience vécue. Ces groupes peuvent également créer une masse critique d'hommes dans la communauté qui sont prêts à faire évoluer les choses. Les séances avec les partenaires des hommes peuvent favoriser la communication et renforcer les compétences relationnelles, afin d'aider les parents à partager les soins aux enfants et la prise de décisions, et à entretenir des relations respectueuses et non violentes (8). (Voir l'étude de cas sur le Rwanda.).

Apporter un soutien personnalisé à domicile

Lorsqu'elles sont bien planifiées, les visites à domicile peuvent constituer l'une des meilleures approches pour échanger avec les hommes s'occupant d'enfants, en les observant avec leurs enfants, et en leur fournissant des retours directs ainsi que des conseils pour renforcer leurs compétences. Ce travail mené auprès des hommes peut être intégré aux programmes existants de visites à domicile, tels que les programmes menés par des agents et agentes de santé communautaires

ou des intervenants et intervenantes de la protection sociale (25). Cela peut nécessiter d'adapter les horaires des visites, de recruter des hommes pour réaliser ces visites, ou d'aborder de nouveaux sujets tels que les interactions père-enfant, la non-violence et les relations familiales équitables.

Apporter un soutien personnalisé grâce au mentorat

Le mentorat est un soutien individuel destiné aux hommes s'occupant d'enfants, offert dans un environnement sûr, souvent par des hommes plus âgés et respectés de la communauté. Le mentorat permet d'adapter le soutien aux besoins de chacun et peut aider à s'adresser aux hommes en fonction de leur situation (17).

Utiliser des approches numériques

De nombreux hommes ont accès à certaines formes de technologie numérique – SMS, applications, médias sociaux et plateformes en ligne – qui peuvent être utilisées pour leur transmettre directement des informations et des messages afin de les encourager à s'impliquer et à interagir avec leurs enfants, et à soutenir leur partenaire. Les messages peuvent être planifiés pour transmettre aux hommes concernés des informations ciblées spécifiques à différentes étapes de la grossesse et aux premières années de leurs enfants, et peuvent être intégrés aux interventions existantes de santé mobile.

Redéfinir la paternité

L'intervention Bandebereho (« modèle ») au Rwanda s'adresse aux pères d'enfants de moins de 5 ans, et comprend environ 15 séances hebdomadaires d'activités participatives et de discussions de groupe, dont plusieurs séances destinées aux couples. Ces séances favorisent une réflexion critique sur les rôles liés au genre, encouragent la participation des hommes aux soins prénatals, à l'accouchement et aux soins aux enfants, et permettent aux hommes et à leurs partenaires d'acquérir des compétences parentales et relationnelles. Le programme, adapté du Programme P, aborde les questions de genre et de pouvoir, la paternité, la communication et la prise de décisions au sein du couple, la violence entre partenaires intimes, les soins aux enfants, le développement de l'enfant et l'engagement des hommes en matière de santé reproductive et maternelle. L'intervention a été mise à l'essai avec plus de 1700 couples entre 2013 et 2015.

Un essai contrôlé randomisé portant sur l'intervention Bandebereho a démontré que celle-ci a permis des améliorations concernant l'assiduité des femmes et des hommes pour les soins prénatals, le temps passé par les hommes à s'occuper de leurs enfants, les relations de couple, la violence des hommes à l'égard des femmes, et l'usage de la violence à l'égard des enfants par les hommes et les femmes (8). Une étude de suivi récente a indiqué qu'un grand nombre de ces impacts s'étaient maintenus six ans plus tard, et a constaté des améliorations concernant les pratiques des

parents, ainsi que les résultats des enfants sur les plans émotionnel et comportemental.

L'intervention Bandebereho est en cours de déploiement dans le système de santé rwandais, avec le soutien du Rwanda Biomedical Centre (RBC), du Rwanda Men's Resource Centre (RWAMREC) et d'Equimundo : Center for Masculinities and Social Justice (anciennement Promundo-US).

Pour plus d'informations, visionner cette [vidéo de présentation de la BBC sur l'intervention Bandebereho](#).



Un père fait preuve de bienveillance et d'orientation en marchant avec ses enfants au Rwanda. © Perttu Saralampi

Poursuivre les efforts

Il existe des possibilités pour les responsables des politiques et de la mise en œuvre des programmes dans chaque pays, quel que soit le point de départ, d'encourager l'engagement des hommes s'occupant d'enfants et de les aider à prodiguer des soins attentifs. Les services qui travaillent avec les femmes, les enfants et les familles peuvent aider les hommes à développer leur plein potentiel en tant que personnes s'occupant d'enfants, en adoptant certaines des mesures présentées dans cette note thématique.

Il existe un nombre croissant d'interventions fondées sur des données probantes qui sont destinées aux hommes s'occupant d'enfants et aux couples, mais la plupart n'ont été mises en œuvre qu'à petite échelle. Une collaboration multisectorielle est nécessaire pour déterminer comment adapter leur contenu et la formation requise, afin qu'elles puissent être intégrées aux services publics – tels que les services de santé, de protection de l'enfance et de protection sociale,

notamment les programmes de transferts en espèces ; cela permettra également de renforcer la base de données probantes concernant leurs effets positifs.

Les méthodologies de recherche sur la mise en œuvre contribueront à ce processus d'adaptation, en nous permettant de comprendre les principaux facteurs de mise en œuvre qui déterminent le fonctionnement de ces programmes, les personnes qui en bénéficient et les manières de les adapter à différents contextes. Une fois les interventions intégrées, un suivi et une évaluation seront nécessaires pour garantir leur qualité, leur fidélité et leur efficacité dans le cadre d'une mise en œuvre à grande échelle.

Au fil du temps, ces changements, associés aux efforts déployés par les communautés pour faire évoluer les normes de genre, peuvent contribuer à normaliser la participation des hommes en tant que personnes s'occupant de leurs enfants de manière bienveillante, engagée et équitable.

Ainsi, davantage de garçons et de jeunes hommes pourront grandir avec des modèles d'hommes s'occupant de leurs enfants, et pourront être encouragés à développer leur propre capacité à prodiguer des soins.

Rappeler

Les efforts visant à favoriser l'engagement des hommes à l'égard des soins attentifs doivent s'inscrire dans le cadre d'un objectif plus large consistant à parvenir à l'égalité des genres.

Renforcer

Les services peuvent être adaptés pour mieux susciter l'intérêt des hommes et les encourager à être plus impliqués auprès de leurs enfants, dès le départ.

Compléter

Un environnement favorable à la participation des hommes doit être créé en faisant évoluer les normes et en adoptant des politiques de soutien.

Ressources utiles

Gender equality action plan, 2026-2029

<https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Gender-Policy-Action-Plan-Compendium.pdf>

Note technique et fiche de conseils sur la parentalité tenant compte des questions de genre

https://www.unicef.org/eca/media/16436/file/Gender_Responsive_Parenting.pdf

https://www.unicef.org/eca/media/16446/file/Tips_on_Gender_Responsive_Parenting.pdf

How to engage men in nurturing care across the early life stages

<https://nurturing-care.org/engaging-men-in-nurturing-care-across-the-life-stages/>

MenCare, une campagne mondiale pour la paternité

<http://men-care.org/>

Promouvoir l'engagement des hommes dans le développement de la petite enfance : Un guide de programmes et d'influence

<https://plan-international.org/publications/promoting-mens-engagement-in-early-childhood-development/>

Program P: a manual for engaging men in fatherhood, caregiving, and maternal and child health

<https://www.mencare.org/resources/program-p/>

Références

1. OMS, UNICEF, Groupe de la Banque mondiale. Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à survivre et à s'épanouir afin de transformer la santé et le potentiel humain. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2018 (<https://www.who.int/fr/publications/item/9789241514064>, consulté le 1er juillet 2022).
2. Tokhi M, Comrie-Thomson L, Davis J, Portela A, Chersich M, Luchters S. Involving men to improve maternal and newborn health: a systematic review of the effectiveness of interventions. *PLoS ONE*. 2018;13(7):e0191620.
3. Diniz E, Brandão T, Monteiro L, Verissimo, M. Father involvement during early childhood: a systematic review of the literature. *Journal of Family Theory & Review*. 2021;13:77-99.
4. Levitov R, van der Gaag N, Greene M, Kaufman M, Barker G. State of the world's fathers: a MenCare advocacy publication. Washington, D.C.: Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender Justice, MenEngage Alliance; 2015 (https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/state-of-the-worlds-fathers_12-june-2015.pdf, consulté le 4 mai 2022).
5. van der Gaag N, Heilman B, Gupta T, Nembhard C, Barker G. State of the world's fathers: unlocking the power of men's care. Washington, D.C.: Promundo-US; 2019 (<https://www.mencare.org/resources/state-of-the-worlds-fathers-unlocking-the-power-of-mens-care/>, consulté le 4 mai 2022).
6. Yargawa J, Leonardi-Bee J. Male involvement and maternal health outcomes: systematic review and meta-analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 2015;69(6):604-612.
7. Fisher J, Cabral de Mello M, Patel V, Rahman A, Tran T, Holton S, et al. Prevalence and determinants of common perinatal mental disorders in women in low- and lower-middle-income countries: a systematic review. *Bull World Health Organ*. 2012;90:139G-49G.
8. Doyle K, Levitov R, Barker G, Bastian GG, Bingenheimer JB, Kazimbaya S, et al. Gender-transformative Bandedereho couples' intervention to promote male engagement in reproductive and maternal health and violence prevention in Rwanda: findings from a randomized controlled trial. *PLoS ONE*. 2018;13(4):e0192756.
9. Feinberg ME, Kan ML. Establishing family foundations: intervention effects on coparenting, parent/infant well-being, and parent-child relations. *J Fam Psychol*. 2008;22:253-63.
10. Comrie-Thomson L, Webb K, Patel D, Wata P, Kapamurandu Z, Mushavi A, Nicholas MA, Agius PA, Davis J, Luchters S. Engaging women and men in the gender-synchronised, community-based Mberekho+Men intervention to improve maternal mental health and perinatal care-seeking in Manicaland, Zimbabwe: a cluster-randomised controlled pragmatic trial. *J Glob Health* 2022;12:04042.
11. Comrie-Thomson L, Gopal P, Eddy K, Baguiya A, Gerlach N, Sauvé C, et al. How do women, men, and health providers perceive interventions to influence men's engagement in maternal and newborn health? a qualitative evidence synthesis. *Soc Sci Med*. 2021;291:114475.
12. Martin SL, McCann JK, Gascoigne E, Allotey D, Fundira D, Dickin KL. Mixed-methods systematic review of behavioral interventions in low and middle-income countries to increase family support for maternal, infant, and young child nutrition during the first 1000 days. *Current Developments in Nutrition*. 2020;4(6):nzaa085.
13. Sarkadi A, Kristiansson R, Oberklaid F, Bremberg S. Fathers' involvement and children's developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. *Acta Paediatrica*. 2008;97(2):153-58.
14. Cabrera NJ, Tamis-LeMonda CS, editors. Handbook of father involvement: multidisciplinary perspectives, second edition. New York: Routledge; 2013.
15. Burgess A. The costs and benefits of active fatherhood: evidence and insights to inform the development of policy and practice. London: Fathers Direct; 2006 (<https://fathers.co.za/wp-content/uploads/2015/02/The-costs-and-benefit-of-active-fatherhood.pdf>, consulté le 4 mai 2022).
16. Digolo L, Asghar K, Berry V, Mitchell S, Rumble L, Alemann C, et al. Evidence review: parenting and caregiver support programmes to prevent and respond to violence in the home. The Prevention Collaborative; 2019 (<https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2019/11/Evidence-Review-Parenting-programmes-lowres-23112019.pdf>, consulté le 4 mai 2022).
17. Ashburn K, Kerner B, Ojamuge D, Lundgren R. Evaluation of the responsible, engaged, and loving (REAL) fathers initiative on physical child punishment and intimate partner violence in Northern Uganda. *Prev Sci*. 2017 Oct;18(7):854-864.
18. MOMENTUM. How to engage men in nurturing care across the life stages. Washington, DC: USAID MOMENTUM Country and Global Leadership; 2022 (<https://nurturing-care.org/engaging-men-in-nurturing-care-across-the-life-stages/>, consulté le 1er septembre 2022).
19. Alemann C, Garg A, Vlahovicova K. The role of fathers in parenting for gender equality. Washington D.C.: Promundo-US; 2020 (https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/sites/23/2020/06/Parenting-Education-the-role-of-fathers-paper_CA.pdf, consulté le 4 mai 2022).
20. Díaz LS, Saldías J, Contreras Y, Pizarro P. Apoyo social para la parentalidad: experiencias en programas de infancia en Chile. *Revista Perspectivas*. 2019;33:31-56.
21. Baird M, Hill E. Paternity leave in the Philippines. Sydney: The University of Sydney, Sydney Southeast Asia Centre; 2019 (https://investinginwomen.asia/wp-content/uploads/2019/05/FS_Paternity-Leave-Philippines.pdf, consulté le 1er septembre 2022).
22. Paulson JF, Bazemore SD. Prenatal and postpartum depression in fathers and its association with maternal depression: a meta-analysis. *JAMA*. 2010;303:1961-1969.
23. Chunling L, Black MM, Richter LM. Risk of poor development in young children in low-income and middle-income countries: an estimation and analysis at the global, regional, and country level. *Lancet Glob Health*. 2018;4(12):e916-22. doi:10.1016/S2214-109X(16)30266-2.
24. Heckman JJ. There's more to gain by taking a comprehensive approach to early childhood development. Chicago: The Heckman Equation; 2017 (https://heckmanequation.org/www/assets/2017/01/F_Heckman_CBAOnePager_120516.pdf, consulté le 10 juillet 2022).
25. Jensen SK, Placencio-Castro M, Murray SM, Brennan RT, Goshev S, Farrar J, et al. Effect of a home-visiting parenting program to promote early childhood development and prevent violence: a cluster-randomized trial in Rwanda. *BMJ Global Health*. 2021;6:e003508.

Soins attentifs pour le développement de la petite enfance

REMERCIEMENTS

Soins attentifs pour le développement de la petite enfance : un cadre pour aider les enfants à SURVIVRE et à S'ÉPANOUIR afin de TRANSFORMER la santé et le potentiel humain (1). Il s'appuie sur les dernières données relatives aux différents stades du développement du jeune enfant et aux politiques et interventions les plus efficaces pour améliorer son développement. L'OMS, l'UNICEF et le Groupe de la Banque mondiale ont défini ce cadre en collaboration avec le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, et le Réseau d'action pour le développement du jeune enfant et de nombreux autres partenaires afin d'établir une feuille de route pour réaliser les objectifs de développement durable ainsi que les objectifs Survivre,

S'épanouir et Transformer de la Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent. Lancé en 2018 avec la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ce cadre souligne : i) les raisons pour lesquelles les efforts visant à améliorer la santé, le bien-être et le capital humain doivent débiter dès les premières années, de la grossesse à l'âge de 3 ans ; ii) les principales menaces pour le développement dans la petite enfance ; iii) la façon dont les soins attentifs protègent les jeunes enfants contre les pires effets de l'adversité et favorisent leur développement physique, affectif, social et cognitif ; et iv) ce dont ont besoin les familles et les soignants pour prodiguer des soins attentifs aux jeunes enfants.

ÉQUIPE DE RÉDACTION :

Kate Doyle (Equimundo), Melanie Swan (Plan International), Sheila Manji (OMS), Bernadette Daelmans (OMS), Margaret Greene (Equimundo), Saif Chaudhury (Plan International).

CONTRIBUTRICES ET CONTRIBUTEURS :

Moses Abiero, Clara Alemann, Asmaa Alkhatib, Avni Amin, Mariam Bandzeladze, Beverly Bicaldo, Julianne Birungi, Betzabe Butron, Liz Comrie-Thomson, Catharina Cuellar, Given Daka, Prof. Hasina Ebrahim, Maya Elliot, Nina Gerlach, Ghassan Issa, Shreyasi Jha, Mary Kabati, Boniface Kakhobwe, Emmanuel Karamage, Giovanna Lauro, Zhao Li, Joan Mutinda, Bezaye Negassa, Lynette Okengo, Dr George Owino, Annie Portela, Chemba Raghavan, Nicole Rodger, Daniel Rojas, Marco Rojas.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

nurturing-care.org
eccdan.org

PARTICIPEZ À LA CONVERSATION

#NurturingCare
@NurturingCare

CONTACT

NurturingCare@who.int



Un père passe du temps à enseigner à son fils son environnement. © Alfred Tschager



Organisation
mondiale de la Santé

unicef
pour chaque enfant



Soins attentifs et engagement des hommes : note thématique [Nurturing care and men's engagement: thematic brief]

ISBN (OMS) 978-92-4-011966-6 (version électronique)
ISBN (OMS) 978-92-4-011967-3 (version imprimée)

© Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), 2025.
Certains droits réservés. La présente œuvre est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.